Neumonías eosinofílicas: la aguda que parece SDRA, la crónica que recae y las que se disfrazan (EGPA, ABPA, fármacos y parásitos)

Basada principalmente en Cottin V. *Eosinophilic lung diseases*. Clin Chest Med 2025;46:667–684, y Carbone RG, et al. *Acute and chronic eosinophilic pneumonia: an overview*. Front Med 2024; complementada con revisiones de 2024–2026 sobre daptomicina, anticuerpos monoclonales y fibrosis en la neumonía eosinofílica crónica (referencias al final).

Versión 1.0 · 1 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

≥25 %
eosinófilos en el lavado broncoalveolar (LBA): define la eosinofilia alveolar

Normal
suele estar la eosinofilia en sangre al ingreso en la forma aguda: el LBA hace el diagnóstico

>50 %
de las neumonías eosinofílicas crónicas recaen al bajar o suspender el esteroide

LO QUE TIENES QUE SABER

- **Toma la biometría y el LBA antes del esteroide.** El esteroide sistémico puede reducir o borrar la eosinofilia y dificultar el diagnóstico.
- **Aguda (NEA):** joven, a menudo fumador reciente o que retomó el tabaco o el vapeo, con fiebre e insuficiencia respiratoria en <1 mes (habitualmente <7 días). Parece neumonía o SDRA; la eosinofilia en sangre aparece días después. Responde al esteroide y no recae si no vuelve a fumar.
- **Crónica (NEC):** mujer de mediana edad con asma, con semanas de tos, disnea y pérdida de peso, eosinofilia marcada y consolidación periférica en lóbulos superiores. Responde en días al esteroide, pero recae con frecuencia.
- **Antes de llamarla idiopática, busca la causa:** fármacos (daptomicina, AINE, antibióticos), tabaco y vapeo, drogas, parásitos, hongos (aspergilosis broncopulmonar alérgica), radioterapia.
- **Las manifestaciones fuera del tórax sugieren sobre todo EGPA** (granulomatosis eosinofílica con poliangitis; también síndrome hipereosinofílico): evalúa el corazón.

1 Definiciones de eosinofilia
2 Clasificación
3 Abordaje: qué pedir y en qué orden
4 Neumonía eosinofílica aguda
5 Neumonía eosinofílica crónica
6 Aguda vs crónica: tabla comparativa
7 Por fármacos: el caso de la daptomicina
8 Las que se disfrazan: EGPA, ABPA, síndrome hipereosinofílico, parásitos
9 Lo que estás haciendo mal
10 Casos y consulta rápida

1 Definiciones de eosinofilia[1]

TÉRMINO	CRITERIO
Eosinofilia en sangre	>500/µL (>0.5 × 10^9/L) o >6 % del diferencial. Leve 500–1500; moderada 1500–5000; grave >5000/µL
Hipereosinofilia en sangre	>1500/µL en 2 determinaciones separadas por al menos 1 mes (≥2 semanas en los criterios del síndrome hipereosinofílico)
Eosinofilia alveolar	≥25 % de eosinófilos en el diferencial del LBA

Las enfermedades pulmonares eosinofílicas infiltran el intersticio y los alvéolos con eosinófilos, **conservando la arquitectura pulmonar**. La interleucina 5 (IL-5) es la citocina central en la producción y el reclutamiento del eosinófilo; de ahí el papel creciente de los anticuerpos anti-IL-5 y anti-receptor de IL-5.[1]

2 Clasificación práctica[1]

	INICIO AGUDO	INICIO CRÓNICO
Solo pulmonar, idiopática	NEA idiopática · síndrome de Löffler	NEC idiopática
Solo pulmonar, con causa	NEA por tabaco o polvos inhalados, fármacos, drogas ilícitas o infecciones	ABPA y síndromes relacionados · parásitos · otras infecciones · radioterapia
Con manifestaciones sistémicas	DRESS · infección parasitaria	EGPA · vasculitis eosinofílica · síndromes hipereosinofílicos

NEA: neumonía eosinofílica aguda. NEC: neumonía eosinofílica crónica. ABPA: aspergilosis broncopulmonar alérgica. DRESS: reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos.

3 Abordaje: qué pedir y en qué orden[1–3]

#	PASO	QUÉ BUSCAS
1	**Biometría hemática antes del esteroide**	Eosinofilia y su magnitud. En la NEC suele ser de 5000–6000/µL (20–30 % de los leucocitos); en la NEA suele ser normal al ingreso y sube en 1 a 7 días.
2	**TC de tórax de alta resolución**	Consolidación periférica de lóbulos superiores (NEC); vidrio deslustrado, engrosamiento septal y derrame pleural bilateral (NEA); bronquiectasias centrales e impactación mucoide (ABPA).
3	**LBA con diferencial y cultivos**	≥25 % de eosinófilos (en la NEC suele ser >40 %) y exclusión de infección. En la NEA es obligatorio: hace el diagnóstico y descarta infección.
4	**Interrogatorio de causas**	Fármacos de las semanas o días previos (consulta pneumotox.com), inicio, cambio o reinicio de tabaco, vapeo, cannabis, cocaína; viajes o residencia en zonas endémicas de parásitos; asma; radioterapia de mama.
5	**Busca manifestaciones extratorácicas**	Mononeuritis, púrpura palpable, glomerulonefritis, miocardiopatía, síntomas generales: orientan a EGPA o síndrome hipereosinofílico. En sospecha de EGPA: ECG, ecocardiograma, NT-proBNP y troponina.
6	**Laboratorio dirigido**	IgE total e IgE específica para *Aspergillus fumigatus* (ABPA), ANCA (EGPA), serología o coproparasitoscópico según exposición. La PCR y la IgE total suelen subir, pero no son específicas.

La **biopsia pulmonar casi nunca es necesaria**: un cuadro clínico-radiológico característico con eosinofilia alveolar marcada confirma la neumonía eosinofílica.[1]

4 Neumonía eosinofílica aguda (NEA)[1,2]

QUIÉN Y CÓMO SE PRESENTA

- Adultos jóvenes previamente sanos, predominio masculino, edad media ~30 años.
- Dos tercios fuman; sin antecedente de asma.
- **Desencadenantes:** inicio reciente de tabaco (reclutas, estudiantes universitarios), cambio de hábito, consumo masivo, reinicio tras abstinencia, saborizantes, tabaquismo pasivo breve, vapeo, aceite de cannabis vaporizado, aguarrás. También tras trasplante alogénico de células hematopoyéticas o con VIH.
- Disnea (100 %), fiebre habitualmente moderada (100 %), tos (80–100 %), dolor pleurítico (50–70 %), mialgias (30–50 %), molestias abdominales (25 %).
- Insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica: frecuente.

IMAGEN Y LABORATORIO

- **Radiografía:** opacidades alveolares e intersticiales bilaterales, sobre todo líneas de Kerley.
- **TC:** nódulos mal definidos en vidrio deslustrado (100 %), engrosamiento septal interlobulillar (90 %), derrame pleural bilateral (76 %), consolidación (55 %). Sin insuficiencia cardiaca, este patrón sugiere NEA.
- **Eosinófilos en sangre normales al ingreso** en la mayoría: por eso se confunde con neumonía infecciosa.
- **LBA:** >25 % de eosinófilos, cultivos estériles. El derrame pleural puede mostrar eosinofilia inespecífica.
- Hipoxemia grave por cortocircuito de derecha a izquierda; si se hacen pruebas funcionales, restricción leve con DLCO baja.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TRABAJO (NEA)[1]	CUMPLE LOS 5
1. Inicio agudo	Manifestaciones respiratorias febriles de ≤1 mes, sobre todo ≤7 días antes de la consulta

2. Imagen	Opacidades difusas bilaterales
3. Hipoxemia	PaO_2 al aire ambiente ≤60 mm Hg, o PaO_2/FiO_2 ≤300 mm Hg, o $SatO_2$ al aire ambiente <90 %
4. Eosinofilia pulmonar	≥25 % de eosinófilos en el LBA (o neumonía eosinofílica en la biopsia, si se hizo)
5. Sin otra causa	Descartar infección y fármacos; el inicio reciente de tabaco o la exposición a polvos inhalados pueden estar presentes

TRATAMIENTO DE LA NEA

- **Prednisona 30 mg/día** es el inicio habitual; la mejoría suele llegar en ~3 días y **2 semanas en total bastan**.[1]
- **Insuficiencia respiratoria:** metilprednisolona IV 1–2 mg/kg/día.[1] Carbone describe hasta 500 mg/día de metilprednisolona en la insuficiencia grave, con paso a prednisona oral 40–60 mg/día al mejorar, por 2–4 semanas y reducción en las semanas siguientes; el esquema óptimo no está definido.[2]
- La imagen y la función pulmonar se normalizan en menos de 1 mes. Choque, falla extrapulmonar o muerte son excepcionales; se ha usado oxigenación por membrana extracorpórea en casos aislados.[1]
- **No recae, salvo que el paciente vuelva a fumar.** Explícale el papel del tabaco (o de la exposición identificada) e insiste en dejarlo.[1]
- Si la respuesta al esteroide es mala, repite la búsqueda de causas.[1]

5 Neumonía eosinofílica crónica (NEC)[1,2]

QUIÉN Y CÓMO SE PRESENTA

- La neumonía eosinofílica más frecuente en zonas no tropicales. Predominio femenino (~2:1), mediana de edad al diagnóstico de 45 años.
- Dos tercios con asma previa; la mitad con atopia. La mayoría no fuma.
- Semanas de tos (90 %), disnea moderada, malestar, pérdida de peso; rinitis o sinusitis (20 %); dolor torácico o hemoptisis (≤10 %). Sibilancias o estertores en un tercio.
- La ventilación mecánica es excepcional. **Sin manifestaciones sistémicas**: si las hay, piensa en EGPA.
- Cerca de 75 % tiene asma en algún momento, que puede ser grave a largo plazo.

IMAGEN, LABORATORIO Y FUNCIÓN

- **TC:** consolidación confluente y vidrio deslustrado, casi siempre bilateral, en lóbulos superiores y periferia subpleural. El "negativo fotográfico del edema pulmonar" en la radiografía aparece en menos de la mitad.[2] Las opacidades migran espontáneamente en una cuarta parte (como en la neumonía organizada criptogénica).[1]
- **Sangre:** eosinofilia marcada, media de 5000–6000/µL (20–30 % de los leucocitos).
- **LBA:** eosinófilos habitualmente >40 %, como célula predominante.
- Mitad con obstrucción y mitad con restricción; hipoxemia leve frecuente.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (NEC)[1]	CUMPLE LOS 4
1. Imagen	Consolidación alveolar difusa con broncograma aéreo y/o vidrio deslustrado, sobre todo de predominio periférico
2. Eosinofilia	≥40 % en el LBA, o eosinófilos en sangre ≥1000/µL
3. Tiempo	Síntomas respiratorios de al menos 2–4 semanas
4. Sin otra causa	Sobre todo, ningún fármaco capaz de inducir eosinofilia pulmonar

TRATAMIENTO DE LA NEC

- La respuesta al esteroide es espectacular: mejoría clínica en ~2 días y aclaramiento radiológico en ~1 semana.
- **El esquema óptimo no está definido.** Cottin propone prednisona **0.5 mg/kg/día por 2 semanas → 0.25 mg/kg/día por 2 semanas** → reducción hasta suspender en **3 meses**; un estudio abierto no encontró diferencia en recaídas entre 3 y 6 meses.[1] Carbone describe 0.5 mg/kg/día por 4–6 semanas, 0.25 mg/kg/día por 8 semanas y luego −5 mg cada mes;[2] otras revisiones describen reducciones de 6 a 12 meses.[6]
- **Recaídas en más de la mitad** al bajar o suspender el esteroide; responden muy bien a reiniciar con **prednisona 20 mg/día**.[1] Hasta 50 % puede requerir esteroide oral a dosis bajas a largo plazo.[2] Avísale al paciente que puede recaer.
- El esteroide inhalado **no previene** recaídas.
- **"Refractaria al esteroide" = reconsidera el diagnóstico.**
- La morbilidad viene de los efectos adversos del esteroide y de la obstrucción persistente al flujo aéreo.

BIOLÓGICOS ANTI-IL-5 EN LA NEC

- Uso fuera de indicación: mepolizumab (anti-IL-5) y benralizumab (anti-receptor de IL-5) con buena respuesta reportada.[1,5,6]
- Cottin los reserva para recaídas frecuentes, asma grave o dependencia de esteroide oral, discutidos caso por caso en un centro experto.[1]
- Dosis reportadas: mepolizumab 100 o 300 mg SC c/4 semanas (en una serie, sin diferencias de eficacia entre ambas); benralizumab 30 mg SC c/4 semanas por 3 dosis y luego c/8 semanas.[5–7]
- La evidencia es de reportes, series y estudios observacionales; no hay ensayos controlados.[5,6] Para dupilumab es aún más limitada.[5]

NO SIEMPRE ES REVERSIBLE: NEC FIBRÓTICA[7]

- En una cohorte de la Clínica Mayo (62 pacientes, sin biológicos), **37 %** mostró fibrosis en tomografías de seguimiento; en la mayoría apareció en los primeros 2 años. No está claro si es progresión, mala clasificación o superposición de patrones.[1]
- 70 % de los fibróticos tenía patrón no NIU (fibrosis en parches o periférica, no la basal de la fibrosis pulmonar idiopática).
- Más riesgo con mayor edad y sexo masculino; el asma pareció proteger.
- En fibrosis progresiva pueden considerarse antifibróticos (nintedanib), aunque en NEC la evidencia se limita a reportes de caso; el papel de los anti-IL-5 para prevenirla es una hipótesis sin estudios prospectivos.

6 Aguda vs crónica: tabla comparativa[1]

	NEUMONÍA EOSINOFÍLICA AGUDA	NEUMONÍA EOSINOFÍLICA CRÓNICA
Inicio	<1 mes (habitualmente <7 días)	>2–4 semanas
Paciente típico	Hombre joven (~30 años), sano	Mujer de ~45 años
Asma	No	Sí (dos tercios previa)
Tabaco	Dos tercios fuman, a menudo de inicio reciente	~10 % fuma
Insuficiencia respiratoria	Habitual	Rara
Eosinofilia en sangre inicial	A menudo no (aparece después)	Sí, marcada
LBA	>25 %	>25 % (suele ser >40 %)
Imagen	Vidrio deslustrado en parches, consolidación, engrosamiento septal, derrame pleural bilateral	Consolidación periférica homogénea, lóbulos superiores
Esteroide	Prednisona 30 mg/día, ~2 semanas	0.5 mg/kg/día y reducción en ≥3 meses (esquema óptimo no definido)
Recaída	No (salvo que retome el tabaco)	Sí, en más de la mitad

7 Neumonía eosinofílica por fármacos: el caso de la daptomicina[1,4]

Cualquier neumonía eosinofílica obliga a revisar los fármacos de las semanas o días previos. Los culpables más frecuentes son antibióticos, AINE y fármacos cardiológicos, reumatológicos y oncológicos; pneumotox.com ayuda a estimar la probabilidad. El derrame pleural o el exantema refuerzan la sospecha. Puede parecer una NEC, una NEA o presentarse dentro de un DRESS.[1]

DAPTOMICINA: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 74 CASOS[4]

- Mediana de edad 67 años; 79 % hombres.
- Dosis mediana 6 mg/kg/día; síntomas tras una **mediana de 19 días** de tratamiento (RIC 12–24).
- Fiebre en 70 % y síntomas respiratorios o hipoxemia en 90.5 %; eosinofilia en sangre en 86.5 % de los casos con dato.
- **LBA: mediana de 20.5 % de eosinófilos**; puede no alcanzar el 25 % aunque haya eosinofilia en sangre.[1,4]
- Imagen: opacidades bilaterales (68 %), vidrio deslustrado (42 %).

QUÉ HACER[4]

- **Suspender la daptomicina** en cuanto se sospecha: se hizo en todos los casos.
- Solo suspensión en 27 %; más esteroide en 51 %; esteroide y antibiótico en 16 %. Ningún esquema se asoció con más recuperación.
- Recuperación en 78 %, mejoría en 19 %, muerte en 2.7 % (2 casos).
- La mejoría suele ser rápida tras suspender, en general en 96 horas o menos.
- Interpretación Fiebre, hipoxemia y opacidades nuevas en un paciente con ~3 semanas de daptomicina no son "falla del antibiótico" hasta demostrar lo contrario.

8 Las que se disfrazan[1,3]

ENTIDAD	CLAVES	DIAGNÓSTICO Y MANEJO
EGPA	Asma (siempre presente; precede a la vasculitis 3 a 9 años), rinosinusitis (~75 %), eosinofilia de 5000–20 000/µL, neumonía eosinofílica parecida a la NEC. ANCA solo en 30–40 % (sobre todo p-ANCA anti-MPO): un ANCA negativo no la descarta. Riesgo cardiaco (miocarditis eosinofílica, muerte súbita) y tromboembólico.	Criterios de trabajo: asma + eosinofilia >1500/µL y/o alveolar >25 % + ≥1 de: mononeuritis múltiple, miocardiopatía atribuida con confianza a la eosinofilia o púrpura palpable; o cualquier manifestación extrapulmonar (no rinosinusitis) con vasculitis en biopsia o con ANCA anti-MPO o anti-PR3. Tratamiento según las guías de EGPA: prednisona 1 mg/kg/día por 3–4 semanas y reducción a 5–10 mg/día a los 6 meses (bolos de metilprednisolona en los casos más graves); ciclofosfamida o rituximab si hay datos de mal pronóstico (miocardiopatía, afección digestiva grave, creatinina >1.7 mg/dL, proteinuria >1 g/día, sistema nervioso central). Mepolizumab 300 mg o benralizumab 30 mg SC c/4 semanas como adyuvantes en EGPA recidivante o refractaria. Evita los antileucotrienos; omalizumab y dupilumab, con precaución.
ABPA	Asma o fibrosis quística mal controlada, tapones de moco marrón, bronquiectasias centrales, impactación mucoide ("dedo de guante"), infiltrados fugaces. Hasta 1–2 % de los adultos con asma.	Criterios ISHAM 2024: predisposición o cuadro compatible + IgE específica para *A. fumigatus* ≥0.35 kUA/L (o prueba cutánea tipo 1 si no hay IgE específica) + IgE total ≥500 UI/mL (menos es aceptable si se cumple todo lo demás) + 2 de: IgG para *A. fumigatus*, eosinófilos ≥500/µL (puede ser histórico), TC compatible (bronquiectasias, tapones de moco, moco de alta atenuación) u opacidades fugaces en la radiografía. El moco de alta atenuación es patognomónico. Prednisolona o itraconazol en monoterapia para el episodio agudo; combinación solo en exacerbaciones recurrentes. Esteroide en ciclo corto (<2 semanas) con itraconazol por 16–32 semanas.
Síndrome hipereosinofílico	Hipereosinofilia ≥1500/µL en 2 determinaciones (intervalo ≥2 semanas) + daño orgánico atribuible, sin otra causa. Neumonía eosinofílica rara; tos seca crónica, derrame pleural, embolia pulmonar, nódulos.	Distinguir variante clonal (neoplásica), reactiva (incluye la variante linfoide) y hereditaria. Diferenciar del edema pulmonar por afección cardiaca.
Parásitos	Principal causa de neumonía eosinofílica en el mundo. *Ascaris*: síndrome de Löffler. *Toxocara*: larva migrans visceral. Filarias: eosinofilia pulmonar tropical. *Strongyloides*: síndrome de hiperinfección en inmunocomprometidos o tratados con esteroide, a veces sin eosinofilia.[3]	Pregunta por viajes y residencia en zonas endémicas. Toda infección por *Strongyloides* debe tratarse.[3] Interpretación En un paciente de zona endémica, descártalo antes de dar esteroide en dosis altas.

Radioterapia	Cuadro parecido a la NEC tras radioterapia por cáncer de mama, con mediana de 3.5 meses (hasta 1 año) después.	Responde al esteroide; puede recaer al suspenderlo.

9 Lo que estás haciendo mal

ERRORES FRECUENTES

- **Dar esteroide "de prueba" antes de la biometría y el LBA.** Puede borrar la eosinofilia y dejar el diagnóstico en el aire.
- **Descartar NEA porque los eosinófilos en sangre son normales.** En la forma aguda suelen ser normales al ingreso.
- **Tratar una NEA como neumonía grave o SDRA sin hacer LBA** en un joven que acaba de empezar a fumar o a vapear.
- **No preguntar por el tabaco con detalle**: inicio reciente, cambio, reinicio, vapeo, cannabis.
- **Llamar idiopática a una NEC sin revisar fármacos, parásitos y *Aspergillus*.**
- **Descartar EGPA porque el ANCA es negativo.** Es positivo solo en 30–40 %.
- **Pensar que el esteroide inhalado evita las recaídas de la NEC.** No las previene.
- **Seguir subiendo esteroide en una "NEC refractaria"** en lugar de replantear el diagnóstico.
- **Atribuir a falla del antibiótico la fiebre y las opacidades nuevas** en un paciente con daptomicina.

10 Casos y consulta rápida

Caso 1

Hombre de 21 años, empezó a fumar hace 3 semanas al entrar a la universidad. Llega con 4 días de fiebre, disnea y dolor pleurítico; $SatO_2$ 86 % al aire ambiente. TC: vidrio deslustrado bilateral, engrosamiento septal y derrame pleural bilateral; ecocardiograma normal; sin fármacos nuevos. Eosinófilos en sangre 300/µL. Recibe antibiótico de amplio espectro sin mejoría.

Respuesta. El perfil (joven, tabaco de inicio reciente, <7 días, hipoxemia, patrón tomográfico sin insuficiencia cardiaca) sugiere NEA; los eosinófilos normales no la descartan. Haz LBA: ≥25 % de eosinófilos con cultivos negativos, junto con los demás criterios, la confirma. Con $SatO_2$ de 86 % ya tiene insuficiencia respiratoria: metilprednisolona IV 1–2 mg/kg/día y, al mejorar, completa ~2 semanas de esteroide por vía oral. Abandono definitivo del tabaco: si vuelve a fumar, puede recaer.

Caso 2

Mujer de 46 años con asma, 6 semanas de tos, disnea y pérdida de 4 kg. Eosinófilos 4800/µL; TC con consolidación periférica en ambos lóbulos superiores. Sin fármacos nuevos ni viajes. Sin neuropatía, púrpura ni sedimento urinario activo.

Respuesta. Cuadro típico de NEC. Toma LBA antes del esteroide si es posible (eosinófilos >40 %). Antes de llamarla idiopática pide IgE total y específica para *A. fumigatus*, ANCA y, si hay exposición, estudio de parásitos. Prednisona 0.5 mg/kg/día por 2 semanas, luego 0.25 mg/kg/día por 2 semanas y retiro en ≥3 meses. Avísale que la recaída es frecuente y que responde a 20 mg/día. Si aparecen manifestaciones extratorácicas, replantea EGPA y evalúa el corazón.

Caso 3

Hombre de 70 años con osteomielitis vertebral, en día 18 de daptomicina 6 mg/kg/día. Nueva fiebre, $SatO_2$ 89 % y opacidades bilaterales. Eosinófilos 1100/µL; LBA con 18 % de eosinófilos y cultivos negativos.

Respuesta. Sospecha neumonía eosinofílica por daptomicina: tiempo de exposición típico y eosinofilia en sangre; un LBA <25 % no la descarta. Suspende la daptomicina y cambia de antibiótico para la osteomielitis; añade esteroide según la gravedad. La mayoría mejora en 96 h o menos.

CONSULTA RÁPIDA	LO ESENCIAL
Definir	Eosinofilia en sangre >500/µL; hipereosinofilia >1500/µL en 2 determinaciones separadas; alveolar ≥25 % en el LBA.
Antes del esteroide	Biometría y LBA con cultivos. Interroga fármacos, tabaco y vapeo, drogas, viajes, asma y radioterapia.
NEA	Joven fumador reciente, habitualmente <7 días, hipoxemia, eosinófilos normales al inicio. Prednisona 30 mg/día ~2 semanas; metilprednisolona IV 1–2 mg/kg/día si hay insuficiencia respiratoria. No recae si no fuma.

NEC	Mujer con asma, semanas, eosinofilia marcada, consolidación periférica superior. 0.5 → 0.25 mg/kg/día y retiro en ≥3 meses (esquema óptimo no definido); recaídas en >50 %: 20 mg/día. Biológicos anti-IL-5 fuera de indicación, caso por caso en un centro experto, si hay recaídas frecuentes, asma grave o dependencia de esteroide.
Banderas de EGPA	Mononeuritis, púrpura, glomerulonefritis, miocardiopatía. ANCA negativo no la descarta. ECG, ecocardiograma, NT-proBNP y troponina.
Fármacos	Daptomicina: ~3 semanas de tratamiento, LBA puede ser <25 %. Suspende primero.

Superíndices: **1** = Cottin, Clin Chest Med 2025; **2** = Carbone, Front Med 2024; **3** = Cottin y Cordier, Allergy 2005; **4** = Gidari, Infection 2024; **5** = Murillo, BMC Pulm Med 2024; **6** = Scelfo, Front Immunol 2026; **7** = Previtero, Eur Respir Rev 2026. Los recuadros "Lo que estás haciendo mal", los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en esas fuentes. Interpretación = lectura editorial de Medicina en Resumen.

Referencias

1. Cottin V. Eosinophilic lung diseases. Clin Chest Med 2025;46:667–684. doi:10.1016/j.ccm.2025.07.007
2. Carbone RG, Puppo F, Mattar E, Roden AC, Hirani N. Acute and chronic eosinophilic pneumonia: an overview. Front Med 2024;11:1355247. doi:10.3389/fmed.2024.1355247
3. Cottin V, Cordier JF. Eosinophilic pneumonias. Allergy 2005;60:841–857. doi:10.1111/j.1398-9995.2005.00812.x
4. Gidari A, Pallotto C, Francisci D. Daptomycin eosinophilic pneumonia, a systematic review of the literature and case series. Infection 2024;52:2145–2168. doi:10.1007/s15010-024-02349-z
5. Murillo AD, Castrillon AI, Serrano CD, Fernandez-Trujillo L. Monoclonal antibodies in idiopathic chronic eosinophilic pneumonia: a scoping review. BMC Pulm Med 2024;24:74. doi:10.1186/s12890-024-02868-3
6. Scelfo C, Simonazzi A, Ruggiero P, Pellegrino MR, Facciolongo N. New perspectives in the treatment of chronic eosinophilic pneumonia in the era of targeted therapies. Front Immunol 2026;17:1893402. doi:10.3389/fimmu.2026.1893402
7. Previtero D, Castelli G, Padrin Y, et al. Fibrotic chronic eosinophilic pneumonia: from inflammation to fibrosis and therapeutic implications. Eur Respir Rev 2026;35:260076. doi:10.1183/16000617.0076-2026

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cada cifra se verifica contra la fuente original. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante. La NEA y la NEC no tienen guías de práctica clínica formales: sus recomendaciones de tratamiento provienen de revisiones de expertos y de estudios observacionales. La EGPA y la ABPA sí tienen guías y criterios propios, que deben consultarse para su manejo completo. Más guías, artículos explicados y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen